SDD 87 Sujet n°1

Spécialité : Dermatologie

Date : 05/05/24
Auteur : HARDY Quentin (DES dermatologie 2022)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (EDN 2023 MAR Toulouse)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de la prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Education/prévention
Item(s) en lien avec la station	350, 155
Situation(s) de départ en lien avec la station	87 : Grosse jambe rouge aiguë
Matériel nécessaire à la station	2 chaises, une table.
Contexte de la station	Aux urgences générales d'un CH périphérique

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne de garde aux urgences adultes d'un grand CH de périphérie. Il est 19h30.

Vous accueillez Mme MICHOU Georgette, 72 ans.
Elle est adressée par son généraliste pour un érysipèle de jambe gauche, non résolutif à J3 d'AMOXICILLINE. Vous trouverez la lettre du généraliste sur le bureau.

Vous concluez à un érysipèle sans signe de gravité.
Vous décidez d'hospitaliser en dermatologie Mme MICHOU.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes

- rechercher (en interrogeant la patiente) les facteurs favorisants de cet érysipèle, et proposer des pistes pour les résoudre
- énoncer les grandes lignes de votre prise en charge dans les jours à venir à l'hôpital (médicamenteuse et non médicamenteuse), ainsi qu'au long cours pour prévenir les récidives

Vous ne devez pas :

- examiner le patient
- réaliser d'ordonnances

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Recherche de facteur favorisant : traite l'intertrigo du pied gauche	1 pt
2.	Recherche de facteur favorisant : préconise le port de compression veineuse au long cours à distance de l'épisode aigu	1pt
3.	Recherche de facteur favorisant : conseille une perte de poids à long terme (obésité)	1pt
4.	Antibiothérapie : IV jusqu'à l'obtention de l'apyrexie. *Car elle est hospitalisée.* *A fortiori devant l'obésité de la patiente, pour une meilleure pharmacocinétique.*	1 pt
5.	Préconise un repos non strict au lit	1 pt
6.	Préconise une surélévation des jambes autant que possible	1 pt
7.	Antalgie adaptée (palier 1 +/- palier 3 si besoin)	1 pt
8.	Arrêt pendant les premiers jours du fait du contexte aigu fébrile : -de la METFORMINE -de l'IRBESARTAN	 1 pt 1 pt
9.	Surveillances glycémiques régulières	1 pt
10.	Initiation d'une insulinothérapie (modalités précises non exigées) en relais de la METFORMINE	1 pt
11.	Mise à jour DTP	1 pt
12.	Prévention des récidives : discute une antibioprophylaxie au long cours (per os ou IM)	1 pt

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	15 points

<u>Éléments de rétroaction :</u>

L'érysipèle est un "incontournable", quelle que soit votre spécialité.
Il importe donc de savoir le prendre en charge de manière optimale.

Il faut penser au contexte aigu, fébrile, induit, et à l'arrêt nécessaire initial de certains traitements (anti-hypertenseurs par exemple).

Enfin, il faut savoir trouver d'éventuelles causes évidentes à cet érysipèle (ulcère, plaie, compression veineuse non utilisée, intertrigo, etc.).

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

<u>Contexte</u> :
Vous êtes interne de garde aux urgences adultes d'un grand CH de périphérie. Il est 19h30.

Vous accueillez Mme MICHOU Georgette, 72 ans.

Elle est adressée par son généraliste pour un érysipèle de jambe gauche, non résolutif à J3 d'AMOXICILLINE. Vous trouverez la lettre du généraliste sur le bureau.

Vous concluez à un érysipèle sans signe de gravité.
Vous décidez d'hospitaliser en dermatologie Mme MICHOU.

Plan de la station ECOS :

Patiente simulée en face de l'interne, autour d'un bureau, sur lequel est disposé la lettre du généraliste.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour Docteur,
Encore un érysipèle… !!
J'en ai marre, dites-moi ce qu'on peut faire pour que cela ne revienne plus !

Identité du patient :

Mme MICHOU Georgette, 72 ans, IMC 34 kg/m2 (98 kg)

Mode de vie :

Très sédentaire. Marche avec une canne. Vit avec son mari au domicile. N'a jamais fumé. Alcool occasionnel. Enfants dans les environs.
Gère ses médicaments seule.

Comportement global :

Patiente très bavarde, mais à l'écoute.

Antécédents personnels :

- Diabète de type 2
- Obésité
- HTA
- Fibrillation atriale
- Insuffisance veineuse
- Maladie rénale chronique

Antécédents familiaux :

- non connus

Médicaments :

METFORMINE, SITAGLIPTINE, IRBESARTAN, APIXABAN, DOLIPRANE à la demande, MOVICOL, ZOPICLONE.

Symptômes positifs (à énoncer seulement si l'étudiant.e demande explicitement):

Auto-médication par IBUPROFÈNE régulière pour douleurs digitales arthrosiques.

Chaussettes de compression veineuse prescrites il y a des années par l'angiologue : non portées car mal tolérées.

Intertrigo interdigital du pied gauche, présent depuis 3 mois, jamais traité.

DTP des 65 ans : non fait.

Constantes :

Paramètres vitaux : température 38,8°C ; normales sinon.

Donnée complémentaire :

- Lettre d'adressage : à remettre au candidat dès le début de l'ECOS

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

Non

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patiente, assise, en face d'un bureau (où est la lettre du généraliste). De l'autre côté : l'étudiant, assis.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- La lettre du généraliste (imprimée, ou sur tablette)
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours